INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP 03-COLONOSCOPIA-Página 1 de 4	
Título do Documento	ORIENTAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA	Emissão: 30/06/2025 Versão: 03	Próxima revisão: 30/06/2027

1. CONCEITO:

1.1 Responsáveis pela execução

Técnico de enfermagem, Enfermeiros e médicos

1.2 Finalidades

- Prestar assistência adequada aos procedimentos de Colonoscopia.

1.3 Indicações

- É indicado para pacientes que tenham sintomas como: alteração do hábito intestinal, diarreia persistente, sangue nas fezes, dores abdominais, perda de peso sem motivo aparente e alteração no formato das fezes.

1.4 Contra Indicação

- As contraindicações são de caráter clínico para os pacientes internados. Além disso, é preciso saber se o paciente tem alguma doença pré-existente que possa impedir a realização do exame.

2. MATERIAIS

- Cateter de O2;
- Sondas de aspiração;
- Pacotes para guarda de próteses e óculos dos pacientes;
- Seringas de 5, 10 e 20ml;
- Agulhas 25x7, 25x8, 40x12;
- Material para punção periférica (abocath 20, 22 e 24, garrote, micropore, tesoura);
- Etiquetas para identificação de medicações e frascos de biópsia;
- Luvas de procedimento;
- Frasco com incidin;
- Frasco com clorexidine alcoólica 0,5%;
- Caixa de descarte para perfurocortantes;
- Maca vestida com lençol e móvel;
- Suporte de soro móvel;
- Escada com dois degraus;
- Monitor multiparâmetros;
- Esfigmomanômetro;
- Estetoscópio;
- Eletrocautério;
- Ramper;
- Computador para laudos.

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

ATIVIDADES: **ETAPAS DO PROCEDIMENTO**

Para a realização de colonoscopia a sala é equipada com torre colonoscópica contendo:

1. Colonoscópio montado;

2. Garrafa com água;
3. Frasco de aspiração de 5000ml;
4. Balde com água e detergente enzimático.

Na mesa auxiliar:

1. Luvas de procedimento;
2. Medicações diluídas para sedação (conforme sala de endoscopia);
3. Frasco de água para injeção de 500ml;
4. Gaze;
5. Cuba redonda pequena;
6. Cuba rim;
7. Índigo carmim 0,8%;
8. Seringa de 50 ou 60 ml;
9. Seringas de 20ml;
10. Seringas de 20ml;
11. Seringas de 10ml com bico Luer Lock (rosca);
12. Frascos de formol para biópsia;
13. Xilocaína gel;
14. Agulha de aspiração;
15. Pinças de biópsia;
16. Alça de polipectomia;
17. Cata pólipo;
18. Gel condutor.

Preparar na régua de gases:

1. Mamadeira de O2 com intermediário;
2. Frasco de aspiração ligado ao frasco da torre;
3. Frasco de aspiração em ar comprimido para aspirar secreções se necessário.

A equipe de enfermagem deve:

1. Recepcionar o usuário;
2. Conferir identificação do usuário com o pedido do exame;
3. Confirmar a retirada de próteses, óculos, bonés e adornos;
4. Posicionar o usuário, mantendo-o aquecido e confortável;
5. Monitorar paciente (FC, Oximetria de pulso);
6. Puncionar acesso venoso em MSE, preferencialmente;
7. Instalar e controlar oxigenoterapia se necessário;
8. Administrar sedativos conforme prescrição médica;
9. Avaliar nível de consciência;
10. Realizar manobras de abertura de vias aéreas/aspiração de secreções se necessário;
11. Auxiliar nos procedimentos médicos;
12. Identificar protocolar e encaminhar as amostras coletadas para exames;
13. Proceder os registros de enfermagem;
14. Transportar usuário para sala de recuperação;
15. Dar o destino adequado à instrumentos e materiais utilizados;
16. Passar o plantão para o funcionário da sala de recuperação.

4. INTERVENÇÕES/OBSERVAÇÕES

Na colonoscopia são realizados procedimentos de biópsia e polipectomia, como na endoscopia, porém com instrumentais específicos.

O fragmento pode ser coletado com a própria pinça, como na biópsia, ou com a alça. Porém, na polipectomia com alça, normalmente, é necessário coletar o pólipo com um cata pólipo. O médico instila água e a aspira. O pólipo vem com a água pela aspiração e fica retido no cata pólipo que deve ser colocado entre o colonoscópio e a borracha de aspiração, na torre.

O paciente deve ser registrado em livro controle, observando o médico que executou o procedimento. O laudo do exame deve ser impresso em duas vias, uma via para o paciente e uma via para arquivo na pasta do médico que efetuou o exame.

As amostras de biópsia devem ser protocoladas para encaminhamento à patologia.

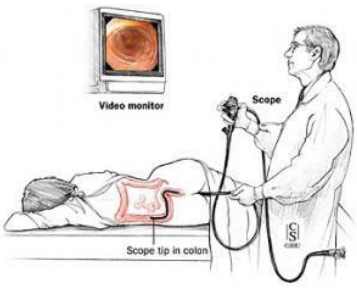
5. ILUSTRAÇÕES / ANEXOS

IMAGEM 01



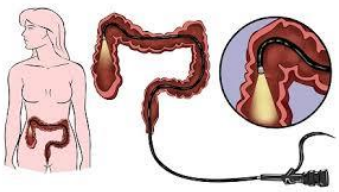
Google imagens

IMAGEM 02.



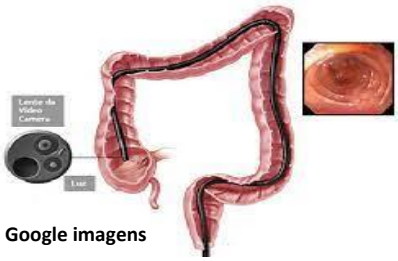
Google imagens

IMAGEM 03.



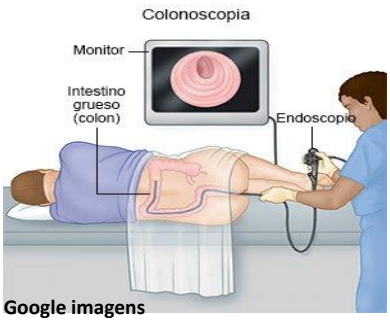
Google imagens

IMAGEM 04.



Google imagens

IMAGEM 05.



Google imagens

6. REFERÊNCIAS

1. TÜRK, Hacer Şebnem et al. Sedação e analgesia em colonoscopia eletiva: propofol-fentanil versus propofol-alfentanil. **Revista Brasileira de Anestesiologia**, v. 63, p. 353-358, 2013.
2. AVERBACH, Marcelo; CORRÊA, Paulo. **Colonoscopia**. Thieme Revinter, 2020.
3. DE SOUZA, Angélica da Costa Ferreira. Colonoscopia e histopatologia do intestino grosso e íleo de cães: série de casos. 2019.
4. JÚNIOR, HUMBERTO FENNER LYRA et al. Importância da colonoscopia no rastreamento de pólipos e câncer colorretal em pacientes portadores de pólipos retais. **Rev Bras Coloproct**, v. 25, n. 3, p. 226-234, 2005.

7. HISTÓRICO DE ELABORAÇÃO/REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA AÇÃO/ALTERAÇÃO
1	01/08/22	Elaboração inicial do documento
2	01/08/23	Alteração na formatação do documento
3	30/06/25	Alteração na formatação do documento

Versão 1 – Elaboração Giulianna Carla Marçal Lourenço Gerente de Enfermagem COREN 315611-ENF	Data: 01/08/22
Versão 2 – Revisão Giulianna Carla Marçal Lourenço Gerente de Enfermagem COREN 315611-ENF **Validação** Nayanne Ingrid F.M. Guerra CCIH/NSP COREN 489616-ENF **Registro, análise e revisão final** Claudio Emananuel Gonçalves Filho Diretor Técnico **Aprovação** Sônia da Silva Delgado Diretora Assistencial	Data: 30/06/25